

B.3.8. : Anamnèse sexuelle

F Stiefel

Service de Psychiatrie de Liaison

CHUV

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

CPS	68	sexual dysfunction
CPS	85	problems of sexual preference, gender identity disorder
CPH	37	preventive recommendations, sexual behavior

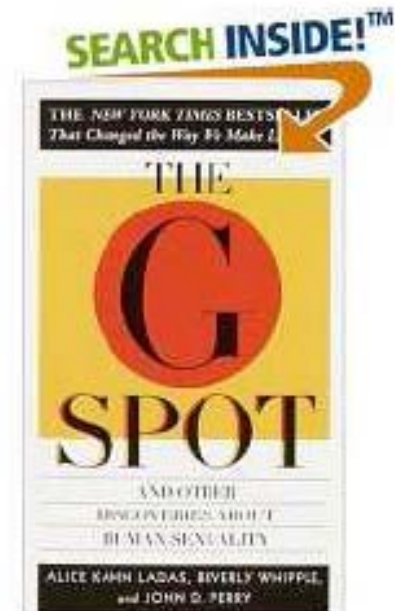
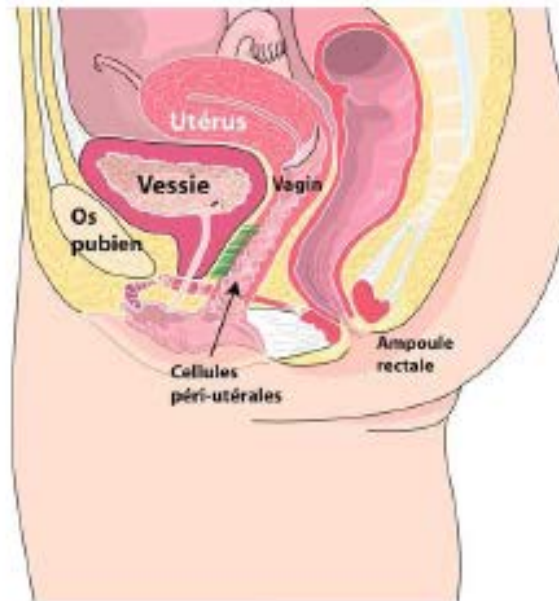
1. Savoir les aspects essentiels de la physiologie sexuelle
2. Connaître les éléments clefs de l'anamnèse sexuelle
3. Identifier les difficultés sexuelles le plus courantes

1. Physiologie de la sexualité

- ✓ Phase d'excitation: érection du pénis et du clitoris / lubrification
- ✓ Phase de plateau: vasodilatation importante du tiers extérieur du vagin et légère des deux tiers intérieurs; pénis en pleine érection; accélération de la respiration et fréquence cardiaque
- ✓ Phase de l'orgasme: contractions rythmiques et involontaires de certaines parties du système reproducteur (à intervalle d'environ 0.8 seconde):
orgasme masculin en deux étapes avec contraction de la prostate et des vésicules séminales qui projette le sperme dans l'urètre, expulsion du sperme; orgasme féminin avec contraction de l'utérus et du tiers extérieur du vagin (15% multiples orgasmes)
- ✓ Phase de résolution: les organes retrouvent leur taille « normale » en moins de 5 minutes (+ détente musculaire)

Le point G

Le point G féminin est situé au à 2 ou 3 cm derrière le bord hyménéal, dans la profondeur de la paroi vaginale antérieure où se situe une zone très innervée et donc très sensible.



???Le point G masculin est situé près de l'urètre à l'intérieur du **rectum**, sur la paroi avant, celle qui sépare le corps de la **verge** de l'**anus**. Le point G masculin est toutefois moins reconnu que son équivalent féminin.

La taille du pénis...

Les mesures moyennes d'un pénis sont au repos de 7 à 10 cm; en érection entre 12 et 18 cm de longueur et de 3 à 4 cm de diamètre

L'anamnèse sexuelle au cabinet médical

- ✓ Problèmes sexuels au cabinet médical 15%
- ✓ Dysfonctionnements sexuels, identité sexuel, orientation sexuel et préférences, abus et violences sexuels, Maladies transmises sexuellement, grossesses non désirées, comportements à risque, infertilité et les conséquences
- ✓ 95% des patients jugent considèrent normal que le médecin investigue la sphère sexuel

April K, Bitzer J: Santé sexuel dans la pratique médicale. FMS 2014; 14(40): 742-6

VIGNETTE CLINIQUE

Un entretien ...

- ✓ Qu'est-ce que fut positif ?
- ✓ Quel climat émotionnel régnait ?
- ✓ Comment les émotions se manifestaient ?
- ✓ Pourquoi ces émotions ?
- ✓ Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différent ?

2. L'anamnèse sexuelle: conditions générales

- ✓ Les patients dévoilent ce qu'un médecin peut entendre
- ✓ Reconnaître ses propres attitudes, angoisses et gênes
- ✓ Accepter ses limites (motivation et orientation du patient)

L'anamnèse sexuelle: éléments clefs

- ✓ Ouverture ou portes d'entrée
- ✓ Expliciter le secret médical
- ✓ Nommer le climat émotionnel
- ✓ Langage adapté (signification des mots)
- ✓ Investigation ≠ inquisition – le patient nous guide
- ✓ Symptôme → caractéristiques → contexte (relationnel) → biographie
- ✓ En vue de... avez vous un/une plusieurs partenaire(s) ?
Comment se passe votre sexualité ? En êtes vous satisfait ? Et votre partenaire ? En souffrez vous ? De ?

Anamnèse sexuelle: spécificités

- ✓ Sexualité comme carrefour entre le biologique, le mental, le social et le culturel
- ✓ Infraction dans le monde intime
- ✓ Interférence par la honte (infraction), l'angoisse (menace), culpabilité (erreur) ou dégoût (connotation)
- ✓ Conséquences des émotions chez le patient/clinicien: silence, évitement, ...

3. Sexualité et dysfonctionnements sexuels

- ✓ La sexualité = toute forme d'expression ou de manifestation consciente ou inconsciente de l'identité sexuée et de l'imaginaire érotique (usage non-sexuel du sexuel et usage sexuel du non-sexuel)
- ✓ Dysfonctionnement sexuels
 - Désir sexuel
 - Excitation sexuelle
 - Plaisir sexuel
 - Autres: vaginisme, dyspareunie

3a) Troubles du désir: anhédonie, aversion, hypersexualité

- ✓ Troubles psychiatriques: dépression, trouble bipolaire, addictions, abus de substances, épuisement, troubles de la personnalité (schizoïde/borderline)
- ✓ Maladies somatiques: diabète, hypertonie, etc.
- ✓ Effets secondaires de traitements: antidépresseurs, antihypertenseurs, chimiothérapie, etc.
- ✓ Contexte relationnel: angoisses, pressions, conflits, etc.
- ✓ Biographie: traumatismes, éducation, homosexualité refoulée, etc.

Troubles du désir: anhédonie

- ✓ Trouble sexuel le plus fréquent
- ✓ Chez la femme, souvent après la naissance du premier enfant (prolactine, surcharge)
- ✓ Chez l'homme, souvent dans le contexte du burnout

Fugl-Meyer A.R., et al. Sexual disabilities, problems and satisfaction in 18 to 74 year – old Swedes.

Scand J Sexology 1999; 2:79-105

3b) Troubles de l'excitation des femmes

- ✓ Manque de lubrification
- ✓ Incidence ↗ avec l'âge (œstrogène ↘)
- ✓ Femmes en ménopause (75%) / Traitements du cancer
- ✓ Dyspareunie: substitution, crèmes

Nusbaum M.R., et al. The high prevalence of sexual concern among women seeking routine gynecological care.

J Fam Pract 2000; 49:229-32

3b) Troubles de l'excitation des hommes

- ✓ Difficultés d'érection
- ✓ 40-50 ans: 10% et 70-80 ans: 50%
- ✓ Souvent associés à des maladies somatiques (première manifestation d'une maladie coronarienne!)
- ✓ Troubles psychiatriques, effets médicamenteux, contexte relationnel

Braun M., et al. Epidemiology of erectile dysfunction.
Int J Impot Res 2000; 12:305-311

3c) Troubles du plaisir

- ✓ Relatés par 10-20% de femmes (anorgasmie, insatisfaction): diverses origines (rapport au corps, besoin de contrôle, angoisses, conflits)
- ✓ Dyspareunie, vaginisme (souvent associé à des traumatismes)
- ✓ Ejaculation précoce de l'homme (le trouble sexuel le plus fréquent de l'homme)

Laumann E.O., et al. Sexual dysfunction in the United States. AMA 1999; 281:537-544

4. Approfondir l'investigation

- ✓ Emergence du trouble (contexte)
- ✓ Fréquence du trouble et variations
- ✓ Durée, intensité, conséquences
- ✓ Facteurs atténuants / aggravants

Contexte mental, social, culturel et relationnel

- ✓ Partenaire, pratiques
- ✓ Regard sur soi, autrui, phantasmes
- ✓ Rencontre physique, initiative, tendresse
- ✓ Communication générale/sexuelle
- ✓ Représentations, préférences, aversions
- ✓ Désir d'enfants, contraception
- ✓ Situation mentale, sociale, culturelle et relationnelle

Biographie I

- ✓ Famille d'origine, développement
- ✓ Relation / sexualité des parents
- ✓ Relation avec les parents
- ✓ Communication au sein de la famille
- ✓ Education, religiosité

Biographie II

- ✓ Développement sexuel: sexualité émergente, climat familial, masturbation, traumatismes
- ✓ Puberté: information, vécu des premières manifestations, identité sexuelle
- ✓ Premiers contacts intimes, expériences sexuelles
- ✓ Expériences relationnelles, grossesses, avortements, satisfactions sexuelles
- ✓ Relations extraconjugales
- ✓ Désirs, plaisirs et satisfactions non sexuels